

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

**CONSENSO INFORMATO PER CHIRURGIA
AMBULATORIALE E LASER DI NEOFORMAZIONI CUTANEE**Modulo di consenso informato per l'asportazione chirurgica
o laser di neoformazioni cutanee in regime ambulatoriale

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD158_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Residenza	
In qualità di (paziente/genitore/tutore)	
Data intervento	

1. Finalità dell'intervento

Le neoformazioni cutanee sono molto diffuse nella popolazione generale e spesso è necessario il trattamento chirurgico per molteplici finalità (curativa, estetica o funzionale). Nei casi in cui la finalità è curativa, è importante chiarire che non sempre il medico riesce a determinare se si tratti di neoformazioni benigne o maligne semplicemente all'osservazione, ma spesso è necessaria la rimozione e l'esame istopatologico per avere una conferma diagnostica. Qualora emerga un quadro di malignità, non è escluso che siano necessari ulteriori trattamenti medico-chirurgici.

2. Anestesia e modalità di intervento

In genere l'intervento viene eseguito in anestesia locale mediante infiltrazione dei tessuti cutanei e sottocutanei di una sostanza anestetica. La tecnica impiegata sarà scelta in funzione delle caratteristiche sia della neoformazione che del paziente.

Asportazione con bisturi: consente l'esame istologico del campione asportato. Prevede l'asportazione di un settore di cute a losanga che includa la lesione, seguita dalla sutura dei margini della ferita con punti di sutura esterni e/o interni.

Asportazione con laser chirurgici: il laser consente di agire su qualsiasi neoformazione cutanea distruggendola con alta precisione. L'asportazione lascia sulla cute una piccola area abrasa che guarisce spontaneamente senza necessità di sutura.

3. Decorso post-operatorio

Il dolore post-operatorio, quando presente, è in genere di lieve entità e controllabile con i comuni analgesici. Si raccomanda di evitare l'uso di farmaci contenenti acido acetilsalicilico perché in grado di indurre sanguinamenti. I punti di sutura vengono rimossi in genere dopo alcuni giorni. Le eventuali ecchimosi permangono per circa 7-10 giorni.

4. Possibili rischi e complicanze

Il fumo limita il flusso del sangue alla pelle e può interferire con i processi di guarigione. Le complicazioni generali includono: emorragia, infezione, ematoma, sieroma e deiscenza delle suture. Le complicazioni specifiche includono: danni a strutture nervose profonde (raro), dolore cronico (raro), alterazioni della pigmentazione (con laser), allergie (generalmente locali), dog-ears (ripiegatura della pelle alle estremità della ferita), exeresi incompleta, recidiva locale e necrosi cutanea (rara).

5. Cicatrici

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Ogni intervento chirurgico produce inevitabilmente cicatrici permanenti e indelebili. In genere, dopo qualche mese, assumono un aspetto poco vistoso. In rari casi, a causa di eccessiva reattività cutanea, è possibile sviluppare cicatrici ipertrofiche o cheloidee. È possibile correggere le cicatrici di qualità scadente con trattamento medico o chirurgico a circa 6-12 mesi dall'intervento.

6. Alternative terapeutiche

Le alternative alla rimozione chirurgica sono tecniche distruttive che non consentono l'esame istologico: elettrocoagulazione, crioterapia, curettage e criochirurgia. Per lesioni neoplastiche, alternative consistono nella radioterapia e nella chemioterapia topica.

7. Istruzioni pre e post-intervento

Pre-intervento: consegnare i referti delle analisi preoperatorie; informare il medico di eventuali terapie in corso; sospendere l'assunzione di farmaci contenenti acido acetilsalicilico almeno una settimana prima; eliminare o ridurre il fumo; segnalare immediatamente raffreddore, mal di gola, tosse o malattie della pelle.

Post-intervento: evitare di bagnare la medicazione; per almeno 6 mesi evitare o ridurre l'esposizione diretta al sole o a lampade abbronzanti, sempre con creme a protezione elevata; seguire le prescrizioni mediche per non compromettere l'esito della procedura.

8. Espressione del consenso

Dichiaro di aver ricevuto informazioni comprensibili ed esaurienti sull'atto sanitario proposto e di essere consapevole del diritto di richiedere ulteriori spiegazioni in ogni momento e di revocare le mie decisioni sino al momento dell'esecuzione della prestazione.

Scelta	Barrare
Acconsento all'intervento di rimozione della neoformazione cutanea	☐
Non acconsento all'intervento di rimozione della neoformazione cutanea	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente (o chi ne fa le veci)		
Professionista Sanitario		